

acompanhamento () consulta

NS 22231696451 / 193

TERESA CRISTINA DA GAMA MEYEN

IDADE: 67

PESO: 81

ALTURA: 162

PROFISSÃO: Professora.

SINTOMAS: Boca seca / Refluxo gástrico

QUEIXAS: Acorda muitas vezes - memória comprometida

MEDICAMENTOS: Domaren retard / acetilix

MÉDICO: Drº Bruno

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates 2x / musculação (2x) / 18

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S / 19

HORA QUE DORME: 22

HORA QUE ACORDA: 6:30

COCHILLO () SIM ☒ NÃO

DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO F.S.

FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 20 anos parou.

TIPO DE RESPIRAÇÃO: não BANHEIRO: 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: ↑ após menop. CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 43 IDO

SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: sinusite

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS Dor lombar

10/06/24 - Avaliação CPAP automático / mare. N30i

17/06/24 P = 9 cm H₂O

IAH = 0,4 e/h

m. de uso: 8h 26min

fuga: 21 l/m (percentil)

Bem adaptada

Natasha

02/07/24 P = 9 cm H₂O

IAH = 1,3 e/h

m. de uso: 7h 7'

fuga: 27,4 l/m

Bem adaptada

Natasha

25/07
24

P = 9 cm H₂O

IAH = 1,7 e/h

m. de uso: 6h 37'

fuga = 7,5 lpm

boa

29/08
24

P = 9,0 cm H₂O

IAH = 1,5 e/h

m. de uso: 7h 8'

Bem adaptada, tosse seca - boa

17/10
24 $P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,9 \text{ elev}$
m. de uso = 6h30'
fuga = 7.2 l/min.

fua.

16/01
25 $P = 9 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso = 6h49'
 $\text{IAH} = 1.1 \text{ elev}$
fuga = 2.5 lpm.

Bem adaptada

fua.

compro o CPAP Básico.

20/03/25 $P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,9, 1h$
m. de uso = 7h15 min
fuga = 14 l/min

Bem Adaptada

Silên

03/07
25 $P = 9,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 0,9 \text{ elev}$
m. de uso: 7h
fuga = 13.8

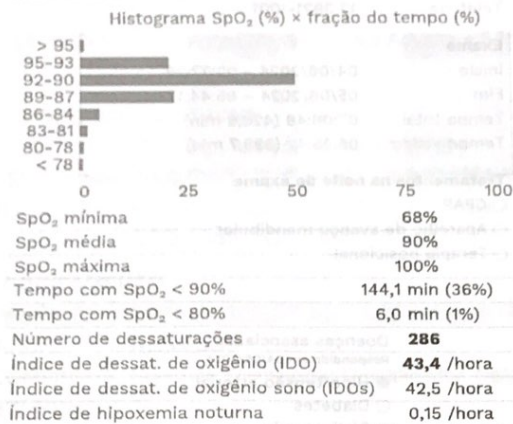
Bem adaptada.

fua

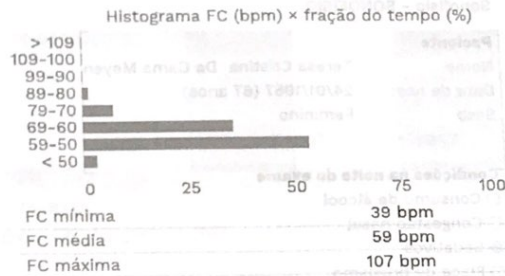
Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)



Frequência Cardíaca (FC)



Sono estimado

Tempo total de sono	401,5 min
Tempo para dormir	18,0 min
Tempo acordado pós-sono	5,0 min
Eficiência do sono	94%

Análise de ronco

Tempo de gravação	427,0 min
Tempo com ronco	397,0 min (93%)



Carga hipóxica - Hypoxic burden

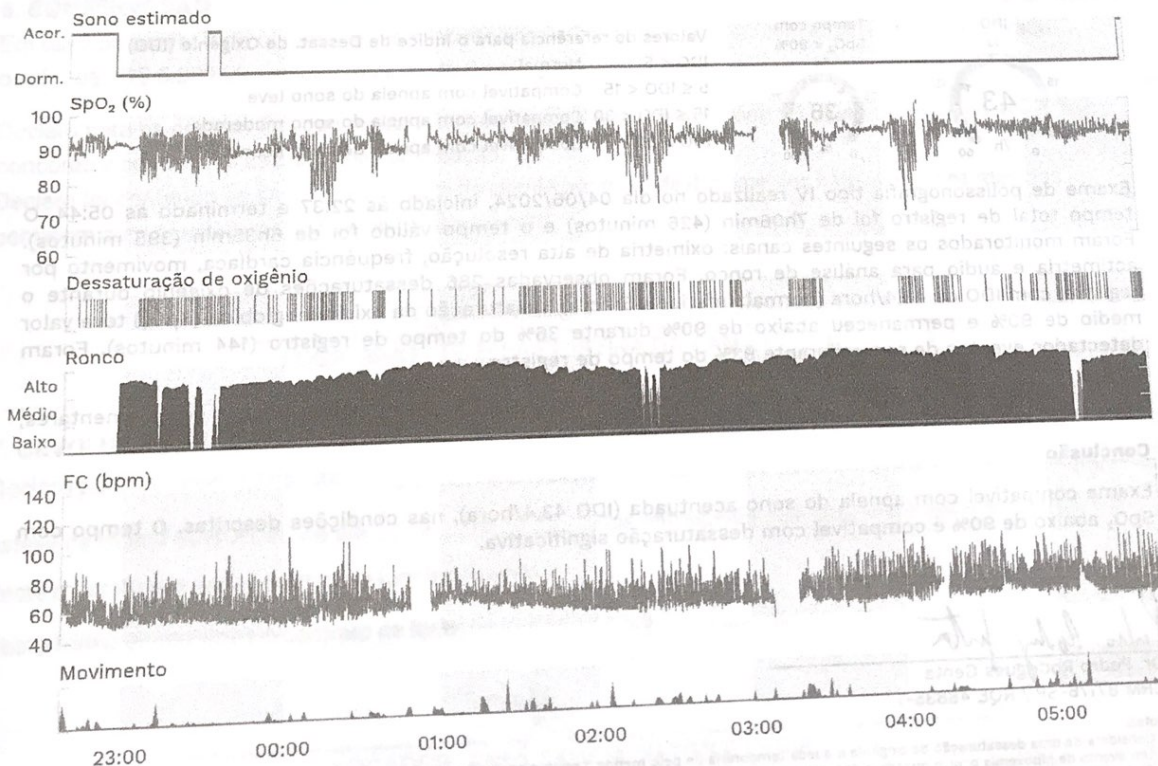
Carga hipóxica (CH) 193,5 %.min /hora

Risco cardiovascular

194 %.min/h

0 Risco menor Risco maior 300

Polissonogramas



Nº de série Oxistar 01670, versão do firmware 01.006.000
Aplicativo: plataforma los, versão 2/1.4.2
Processamento: examprocess-1.1.0, examreport-1.0.1
Documento gerado em 05/06/2024 às 10:56:37 BRT

Ref.: 100-5166950VR

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Teresa Cristina Da Gama Meyen

Data de nasc. 24/01/1957 (67 anos)

Sexo Feminino

Exame

Início 04/06/2024 - 22:37:29

Fim 05/06/2024 - 05:44:17

Tempo total 07:06:48 (426,8 min)

Tempo válido 06:35:42 (395,7 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☒ Sedativos
☐ Placa de bruxismo

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço mandibular
☐ Terapia posicional

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 04/06/2024

Peso 81 kg

Altura 1,62 m

IMC 30,9

Sintomas

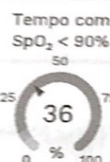
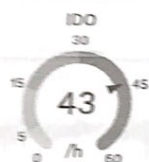
Respondido em 04/06/2024

- ☒ Ronco alto e frequente
☐ Sonolência excessiva diurna
☐ Sono não reparador
☐ Despertares frequentes
☐ Engasgos noturnos
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Cefaleia matinal
☐ Dificuldade de concentração
☒ Perda de memória
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas

Respondido em 04/06/2024

- ☒ Hipertensão arterial
☐ Diabetes
☐ Dislipidemia
☐ Câncer
☐ Depressão
☐ Arritmia cardíaca
☐ Infarto agudo do miocárdio
☐ Angina
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Bronquite / Enfisema
☐ Asma

Resultado

Valores de referência para o Índice de Dessat. de Orogênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 04/06/2024, iniciado às 22:37 e terminado às 05:44. O tempo total de registro foi de 7h06min (426 minutos) e o tempo válido foi de 6h35min (395 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 286 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 43,4/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 90% e permaneceu abaixo de 90% durante 36% do tempo de registro (144 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 93% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 43,4/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂).
2. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%.
3. Os índices das notas 1 e 2 correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
4. A correlação entre o índice de carga hipóxica e risco cardiovascular é baseada no artigo The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure (Ali Azarbarzin et al, 2020).